

Urgences 4

Site: [Moodle Université de Genève](#)
Cours: Compétences cliniques en 3e année Bachelor
Livre: Urgences 4

Imprimé par: Damien Fulliquet
Date: jeudi 8 mai 2025, 11:54

Table des matières

1. Organisation

2. Objectifs spécifiques

3. Références

4. Déroulement et objectifs spécifiques du séminaire

4.1. Annexe 1 : Algorithme de l'arrêt cardiaque pédiatrique pour un seul sauveteur

4.2. Annexe 2 : Algorithme de l'arrêt cardiaque pédiatrique pour 2 sauveteurs ou plus

4.3. Annexe 3 : Etouffement

1. Organisation

Personnes Concernées

- Responsable du séminaire : Dre Alice BORDESSOULE, HUG-Soins intensifs médico-chirurgicale pédiatrique (USI)

Thème du séminaire

Réanimation pédiatrique

Méthode d'enseignement

- Sessions de deux heures.
- Groupes d'env. 10 étudiants pour un formateur.
- Enseignement théorique puis exercices pratiques sur mannequins

Matériel d'enseignement

- Powerpoint.
- Quatre mannequins pédiatriques.
- Matériel de support respiratoire

Objectifs

Les objectifs d'apprentissage sont [consultables en ligne sur LOOOP](#).

2. Objectifs spécifiques

- Assimiler la séquence: hypoxémie arrêt cardiaque secondaire, propre à l'enfant.
- Connaître l'épidémiologie de l'arrêt respiratoire pédiatrique.
- Reconnaître l'arrêt respiratoire imminent ou effectif: pattern respiratoires (respiration périodique, apnée centrale ou obstructive).
- Organisation de la réanimation, appel, répartition des tâches.
 - **A. Libération des voies aériennes :**
 - positionnement de la tête/mandibule.
 - **B. Ventilation :**
 - bouche à nez / bouche à bouche nez;
 - masques (types, tailles);
 - fréquence, amplitude.
 - **C. Massage cardiaque externe**
 - Deux pouces, une main, deux mains;
 - Localisation
 - Fréquence, amplitude.
- **Contrôle** de l'efficacité des actions entreprises.
- **Aborder** l'arrêt de réanimation / attitude.
- **Connaître l'existence** des voies d'accès vasculaire transcutanée et intra-osseuse.
- **Connaître** la manœuvre de Heimlich et son équivalent chez le petit enfant et le nourrisson

3. Références

Lecture de Référence

- DL Atkins et al. **Part 11: Pediatric Basic Life Support and Cardiopulmonary Resuscitation Quality.** Circulation 2015; 132: S519-S525

Pour en savoir plus

- Kitamura T. et al.: **Conventional and chest-compression-only cardio-pulmonary resuscitation by bystanders for children who have out-of-hospital cardiac arrests: a prospective nation wide, population based cohort study.** Lancet 2010; 375 (9723):1347-54
- Young KD, Gausche-Hill M, McClung CD, Lewis RJ. A Prospective, **Population-Based Study of the Epidemiology and Outcome of Out-of-Hospital Pediatric Cardiopulmonary Arrest.** Pediatrics 2004; 114 :157-164.
- Schindler MB, Bohn D, Cox P. et al. **Outcome Out-of-Hospital Cardiac or Respiratory Arrest in Children.** N. Engl. Med. 1996, 335: 1473-1479.

4. Déroulement et objectifs spécifiques du séminaire

• A. Introduction

A la fin de ce séminaire, l'étudiant devrait être capable de:

1. Décrire les particularités pédiatriques d'une insuffisance ou d'un arrêt respiratoire :

- Séquence
 - 1 respiration : périodique → apnée
 - 2 cardiovasculaire : bradycardie → asystolie.

2. Connaître l'épidémiologie de l'insuffisance respiratoire et de l'arrêt cardio-respiratoire et son pronostic désastreux lorsqu'il survient en-dehors de l'hôpital :

- Respiratoires hautes :
 - épiglottite;
 - faux croup;
 - corps étranger.
- basses :
 - bronchiolite;
 - asthme;
 - pneumonie.
- Centrales :
 - méningite;
 - mort subite.
- Secondaires :
 - chute du débit cardiaque

3. Discuter de la séquence de prise en charge (ABC versus CAB) et des bases physiologiques pour la réanimation (débit coronarien, troubles du rythme, cycles de 15 ou 30 compressions).

B. Conduite Pratique

- Objectifs pour une **réanimation de qualité** :
 - S'assurer d'une fréquence de massage adéquate
 - S'assurer d'une profondeur de massage adéquate
 - Permettre un retour complet du thorax avant la prochaine compression
 - Minimiser les interruptions
 - Eviter une ventilation excessive

- Connaître les **algorithmes** de réanimation (cf pages suivantes)

• Massage cardiaque

Âge	Amplitude	Fréquence
	1/3 du diamètre AP	100-120 /min
nourisson	~4 cm	100-120 /min
enfant plus âgé	~5 cm	100-120 /min

- Compression : 50% du cycle, permettre le retour complet du thorax à la position initiale entre 2 compressions

- **Libérer les voies aériennes :**

- Vérifier la position du patient en décubitus dorsal.
- Contrôler la position de la langue et l'absence de corps étranger dans la cavité buccale.
- Position de la tête "nez au zénith".
- Plaquer la mâchoire inférieure (mandibule) contre la mâchoire supérieure (maxillaire).

- **Respiration artificielle**

- en fonction de l'âge :
 - bouche à bouche + nez;
 - bouche à bouche (pincer le nez) ou bouche à nez (fermer la bouche).
- 2 insufflations de 1-2 secondes, en soufflant jusqu'à ce que l'on observe un mouvement du thorax et de l'abdomen supérieur.
- Fréquence : 12-20/min
- Contrôle continu de l'efficacité de la ventilation (mouvements thoraciques, expiration patient).
- *Ventilation au masque :*
 - taille et type adaptés;
 - appliquer sur nez et bouche;
 - fréquence identique à celle décrite plus haut

- **Continuer la réanimation**

- 30 : 2 (si deux sauveteurs : 15 : 2) jusqu'à l'arrivée des secours

- **Utilisation du défibrillateur :**

- Utiliser un défibrillateur dès que possible.
- Défibriller uniquement ces rythmes :
 - Fibrillation ventriculaire
 - Tachycardie ventriculaire sans pouls

- **Corps étrangers**

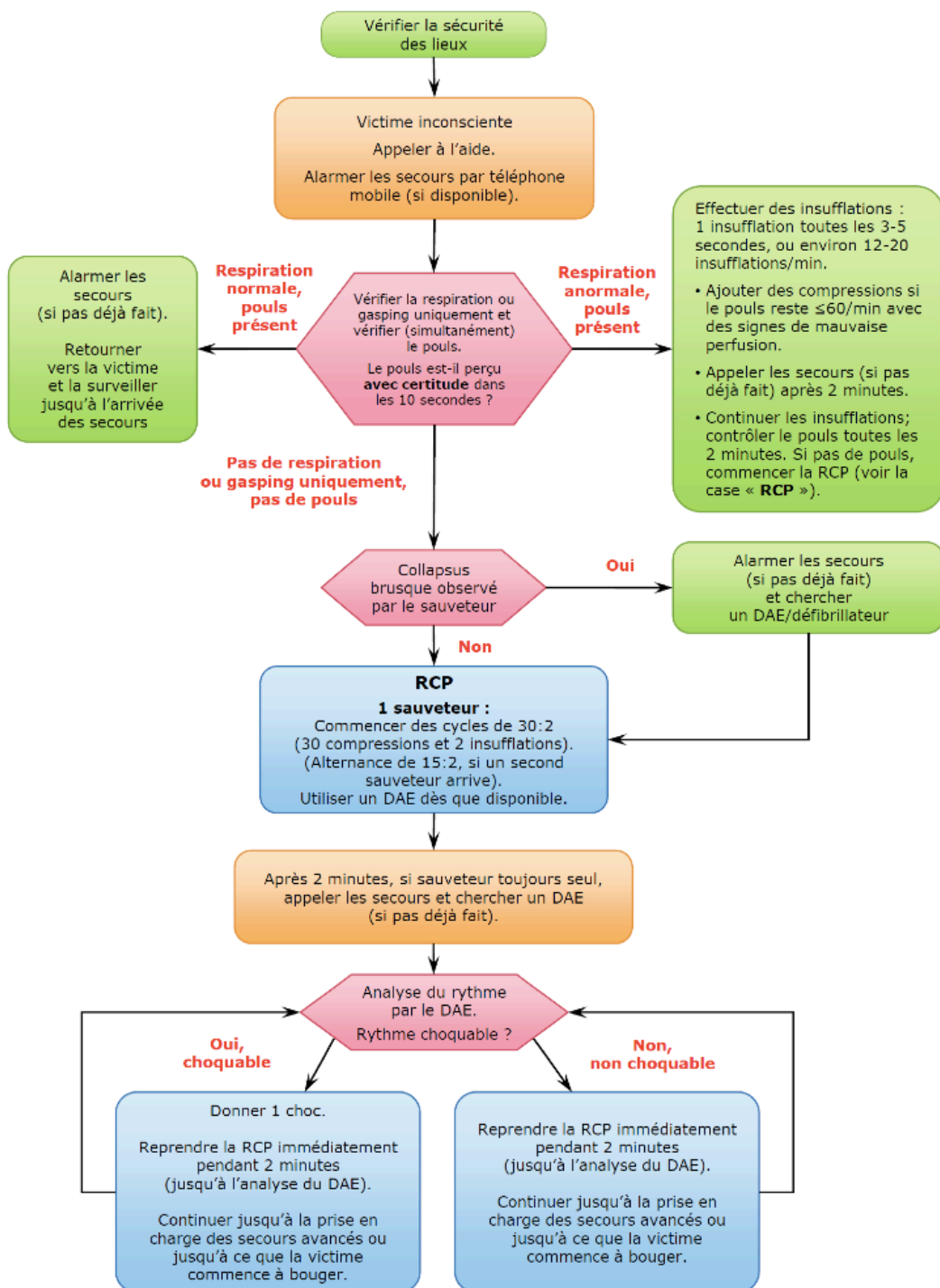
- Connaître les principes de prise en charge :
 - Patient qui tousse activement : encourager à tousser
 - Patient avec toux inefficace mais encore conscient : manœuvre de Heimlich
 - Patient avec toux inefficace et inconscient : massage cardiaque et ventilation

4.1. Annexe 1 : Algorithme de l'arrêt cardiaque pédiatrique pour un seul sauveteur

BLS pour professionnel de la santé

Algorithme de l'Arrêt Cardiaque Pédiatrique pour un seul sauveteur

Mise à jour 2015

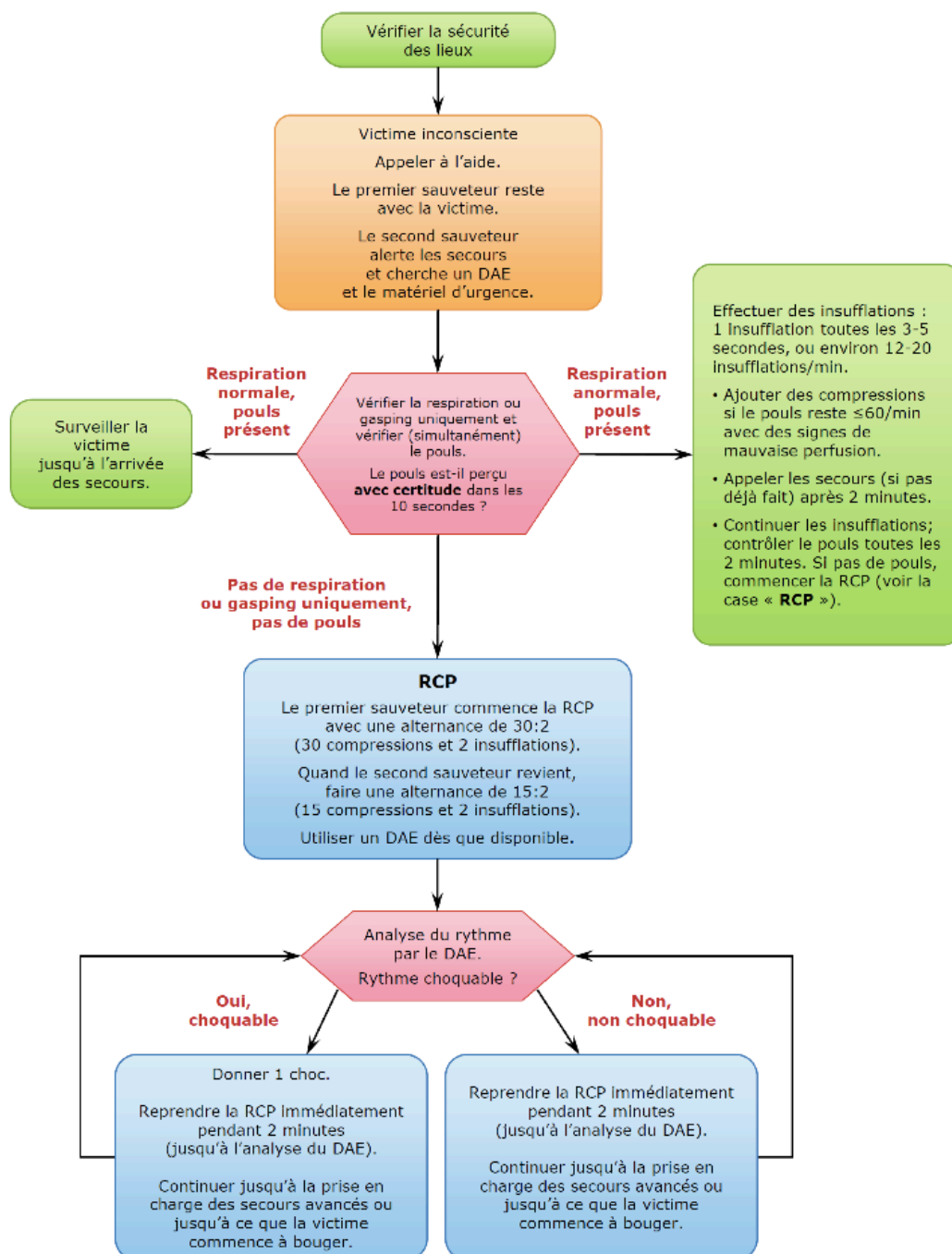


4.2. Annexe 2 : Algorithme de l'arrêt cardiaque pédiatrique pour 2 sauveteurs ou plus

BLS pour professionnel de la santé

Algorithme de l'Arrêt Cardiaque Pédiatrique pour 2 sauveteurs ou plus

Mise à jour 2015



4.3. Annexe 3 : Etouffement

